

跳到主要內容 :: | 網站導覽 (/sitemap_new) | 登入 (/gslogin) | 註冊 (/gspsignup)



衛生福利部食品藥物管理署

藥品仿單查詢平台

(/)

::: 公告訊息 (/notice) 仿單查詢 (/im) 批次訂閱 (/im_batch)
訂閱清單 (/im_subscribe) 藥品外觀資料查詢 (/shape_list)

:::

字級

中文品名 ▶ 嬰護寧六合一疫苗

英文品名 ▶ **INFANRIX HEXA**

許可證號 ▶ 衛署菌疫輸字第**000797**號

藥品類別 ▶ 須由醫師處方使用

劑型 ▶ 凍晶注射劑

申請商名稱 ▶ 荷商葛蘭素史克藥廠股份有限公司台灣分公司

申請商地址 ▶ 臺北市大同區承德路**1**段**2**號**20**樓

發證日期 ▶ **93-10-14**

有效日期 ▶ **118-10-14**

通關簽審文件編號 ▶ **DHA01000079703**

限制項目 ▶ 輸 入

包裝 ▶ 預充式注射針筒
小瓶

主製造廠

製造廠名稱 ▶ **GlaxoSmithKline Biologicals** (製程：中間體製造)

製造廠地址 ▶ **637 Rue des Aulnois 59230 Saint Amand Les Eaux, France (France)**

- 製造廠名稱 ▶ **GlaxoSmithKline Biologicals** (製程：調液、凍晶、充填、包裝)
- 製造廠地址 ▶ **637 Rue des Aulnois 59230 Saint Amand Les Eaux, France (France)**
- 製造廠名稱 ▶ **GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.** (製程：原料藥製造、放行廠)
- 製造廠地址 ▶ **89 RUE DE L'INSTITUT 1330 RIXENSART, BELGIUM (Belgium)**

次製造廠

- 製造廠名稱 ▶ **GlaxoSmithKline Biologicals Kft** (製程：原料藥製造廠)
- 製造廠地址 ▶ **Homoki Nagy Istvan ucta 1, 2100 Godollo, Hungary (Hungary)**
- 製造廠名稱 ▶ **裕利股份有限公司** (製程：二級包裝廠)
- 製造廠地址 ▶ **桃園市大園區和平里1鄰開和路91號 (TAIWAN, ROC)**
- 製造廠名稱 ▶ **GlaxoSmithKline Biologicals S.A.** (製程：原料藥製造；調液、凍晶、充填、包裝)
- 製造廠地址 ▶ **Parc de la Noire Epine, Avenue Fleming 20, Wavre, 1300, Belgium (Belgium)**
- 製造廠名稱 ▶ **GlaxoSmithKline biologicals** (製程：原料藥製造廠)
- 製造廠地址 ▶ **10 Tuas south Avenue 8, Singapore 637421 (Singapore)**

(/im_shape/衛署菌疫輸字第000797號)

(/compare/衛署菌疫輸字第000797號)

全部縮合

1 性狀

1.1 有效成分及含量

泡製之後，一劑(0.5毫升)含有：

白喉類毒素 ¹	30個國際單位(IU)以上
破傷風類毒素 ¹	40個國際單位(IU)以上
百日咳球桿菌抗原	
百日咳類毒素(PT) ¹	25微克
絲狀血凝素(FHA) ¹	25微克
Pertactin (PRN) ¹	8微克
B型肝炎表面抗原(HBs) ^{2,3}	10微克
小兒麻痺病毒(去活性)(IPV)	
第1型(Mahoney病毒株) ⁴	40 D抗原單位
第2型(MEF-1病毒株) ⁴	8 D抗原單位
第3型(Saukett病毒株) ⁴	32 D抗原單位
b型嗜血桿菌多醣體(囊多醣，PRP) ³	10微克
與破傷風類毒素結合，做為載體蛋白	20-40微克
¹ 吸附於氫氧化鋁水合物(Al(OH) ₃)	0.5毫克Al ³⁺
² 藉由重組DNA技術在酵母菌(<i>Saccharomyces cerevisiae</i>)內生產	
³ 吸附於磷酸鋁(AlPO ₄)	0.32毫克Al ³⁺
⁴ 在VERO細胞內繁殖	

疫苗製造過程中使用甲醛、新黴素和多粘菌素，因此可能含有這些殘留物質(見4. **禁忌**)。

賦形劑與已知的影響

疫苗每劑量含有0.057奈克的對胺基苯甲酸和0.0298微克的苯丙胺酸(見5. **警語及注意事項**)。

有關賦形劑組成，見1.2 **賦形劑**。

1.2 賦形劑

Hib粉末：

乳糖

DTPa-HBV-IPV懸液：

氯化鈉 (NaCl)

Medium 199〔作為穩定劑之用，包含胺基酸(苯丙胺酸)、礦物鹽(鈉及鉀)、維他命(對胺基苯甲酸)和其他物質〕

注射用水

有關佐劑部分，見1.1 **有效成分及含量**。

1.3 劑型

供泡製成注射用懸浮液的粉劑和懸浮液

1.4 藥品外觀

白喉/破傷風/非細胞性百日咳、B型肝炎、去活性小兒麻痺、與b型嗜血桿菌(吸附性)疫苗

疫苗的DTPa-HBV-IPV成分為混濁的白色懸浮液。存放時，會觀察到白色沈澱物與透明無色的上清液。這是正常現象。

疫苗的Hib成分為白色粉劑。

2 適應症

Infanrix hexa適用於6週大以上之嬰兒及幼童的基礎免疫接種及追加接種，以對抗白喉、破傷風、百日咳、B型肝炎、小兒麻痺、及b型嗜血桿菌。

應依照官方建議使用Infanrix hexa。

3 用法及用量

3.1 用法用量

[劑量]**基礎免疫接種**

基礎疫苗接種時間表中共包含3劑，每劑0.5毫升。兩劑間應至少間隔1個月以上。

若接種疫苗者出生時已接種一劑B型肝炎疫苗，方可根據EPI時間表(擴充性免疫接種計劃；出生後第6、10、14週)來接種Infanrix hexa。

當地已建立之B型肝炎免疫預防措施應予保留。

在接種疫苗者出生時已接種一劑B型肝炎疫苗的情況下，Infanrix hexa可以作為六週大以上嬰兒之第二劑。如果嬰兒滿六週大之前必須接種第二劑B型肝炎疫苗，則應接種單價B型肝炎疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組建議：新生兒應於出生24小時內接種第一劑單劑型之B型肝炎疫苗，第二劑起才可採用六合一疫苗。

而母親為HBeAg(+)或HBsAg RPHA ≥ 2560之新生兒則仍應於出生後立即接種一劑B型肝炎免疫球蛋白。本項六合一疫苗B型肝炎抗原每劑含量為10mcg，如果採用本疫苗其接種時程可採1.5個月、3個月、6個月實施。

追加免疫接種

15-18個月追加接種。

曾有臨床試驗在完成Infanrix hexa基礎免疫接種後使用其它混合疫苗作為研究，證實其它也可以當作追加劑的混合疫苗包括白喉/破傷風/非細胞性百日咳混合疫苗(DTPa)，白喉/破傷風/非細胞性百日咳與b型嗜血桿菌混合疫苗(DTPa/Hib)，白喉/破傷風/非細胞性百日咳、去活性小兒麻痺與b型嗜血桿菌混合疫苗(DTPa-IPV/Hib)以及白喉/破傷風/非細胞性百日咳、B型肝炎、強化去活性小兒麻痺混合疫苗(DTPa-HBV-IPV)。

對早產嬰兒(懷孕24週之後出生)，可採用與足月生產之嬰兒相同的劑量與接種時間表。

[用法]

Infanrix hexa應以深部肌肉注射方式投予。

4 禁忌

對疫苗有效成分、或其賦形劑、殘餘物質過敏者(見1.1 有效成分及含量及1.2 賦形劑)。

先前於接種白喉/破傷風/百日咳疫苗、B型肝炎疫苗、小兒麻痺疫苗或Hib疫苗過敏者。

如果兒童曾經在接種含有百日咳成分之疫苗後的七天之內發生病因不明之腦病變，則應禁用Infanrix hexa。在此情況下，應停止接種百日咳疫苗，並繼續接種白喉-破傷風類毒素、B型肝炎疫苗、去活性小兒麻痺疫苗及Hib疫苗。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

與其它疫苗一樣，對急性嚴重發燒性疾病患者，應延後接種Infanrix hexa。但輕度的感染現象則非禁忌症。

在接種疫苗之前，應先審閱其病歷(特別是有關其先前之疫苗接種與可能發生之不良反應的記錄)，並進行臨床診察。

並非所有的疫苗接種者都會產生具保護性的免疫反應(見10.2 藥效藥理特性)

Infanrix hexa並不能預防除白喉桿菌(*Corynebacterium diphtheriae*)、破傷風芽胞梭菌(*Clostridium tetani*)、百日咳桿菌(*Bordetella pertussis*)、B型肝炎病毒、小兒麻痺病毒或b型嗜血桿菌(Hib, *Haemophilus influenzae* type b)以外之病原體所引起的感染症。由於引起D型肝炎之病原體(delta agent)必須在B型肝炎病毒同時存在時才能複製造成感染，因此接種本項疫苗亦可同時預防D型肝炎。

曾發生下列狀況者需經專科醫師評估後再接種：

- 先前接種DTaP或DTP後48小時內曾發生不停嚴重哭鬧超過3小時、虛脫(collapsed)或類休克狀態(shock-like state)、發燒超過40.5°C(105°F)，或接種後3天內曾發生痙攣(seizure)且無法以其他原因解釋者。
- 先前接種含破傷風疫苗後6週內曾發生過GBS(Guillain-Barré syndrome)者。
- 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生Arthus過敏反應者，如果有必要考慮追加含破傷風類毒素疫苗則應間隔10年以上。

在某些狀況之下，如百日咳的發生率偏高時，接種疫苗的潛在利益可能會超越其潛在的危險性。

對患有進行性神經疾患(包括嬰兒點頭性痙攣、未獲控制之癲癇或進行性腦病變)的兒童，最好將百日咳疫苗(Pa或Pw；非細胞性或全細胞性)的接種時間延遲到病情獲得矯治或穩定之後。不過，必須先審慎考量個別的風險效益狀況，再做出是否施打百日咳疫苗的決定。

與所有的注射用疫苗一樣，應隨時準備適當的醫療監督與措施，以防接種此疫苗後發生罕見的過敏休克反應。

對患有血小板減少症或出血性疾病的患者投予Infanrix hexa時應小心；因為這些患者在接受肌肉注射之後可能會發生出血的現象。

切勿以靜脈或皮內注射的方式投予Infanrix hexa。

Infanrix hexa的禁忌症並不包括發燒性痙攣病史、痙攣家族史或嬰兒猝死症候群(SIDS)家族史。有發燒性痙攣病史之接種者應於接種後2至3天內密切追蹤是否有不良反應發生。

臨床研究的資料顯示，將Infanrix hexa與結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，出現發燒反應的比例要高於單獨接種Infanrix hexa。同時接種Infanrix hexa與Prevenar 13時，痙攣(併有或未併有發燒現象)及低張性低反應性現象(HHE)的通報率有升高的現象(見 不良反應)。

應依據各地的治療指引進行退燒處置。如果有痙攣疾病或熱痙攣病史，應注意依據台灣相關指引進行退燒處置。

在接種疫苗之後，甚至於接種疫苗前，可能會因為對針頭注射產生心理性反應而發生昏倒的狀況。因此，備妥適當處置以避免因昏倒所造成的傷害是很重要的。

特殊族群

人類免疫不全病毒(HIV)感染症並未被認為是一個禁忌症。免疫功能受到抑制的患者，於接種疫苗之後，可能無法產生預期的免疫反應。

臨床資料顯示，Infanrix hexa可施打於早產兒。但是，一如對此族群的預期，有些抗原所誘發的免疫反應較低(見8. 副作用/不良反應與10.2 藥效藥理特性)。對極早產的嬰兒(懷孕≤28週出生)，以及有呼吸系統發育不成熟之過往病史的嬰兒，在給予基礎免疫接種系列時，應考慮發生呼吸暫停的潛在風險，以及進行48-72小時之呼吸監視的必要性。由於接種疫苗對此類嬰兒的效益極高，因此不可停止或延後接種疫苗。

對實驗室檢驗的干擾

由於Hib囊多醣抗原會經由尿液排出，因此，在接種疫苗後2週內，尿液檢驗會呈現陽性反應。在此期間應進行其他檢驗，以確認是否感染Hib。

賦形劑與已知的影響

Infanrix hexa包含對胺基苯甲酸，可能會造成過敏反應(可能延遲)，特別是支氣管痙攣。

疫苗每劑量含有0.0298微克的苯丙胺酸。如果病人有苯丙酮尿症(PKU)則苯丙胺酸可能有危害，這是一種罕見的遺傳性疾病，因為身體無法適當的排除苯丙胺酸，造成其堆積。

疫苗每劑量含有少於1毫莫耳的鈉(23毫克)，基本上"無鈉"。

疫苗每劑量含有少於1毫莫耳的鉀(39毫克)，基本上"無鉀"。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

由於Infanrix hexa並非供成人使用，因此，目前並無有關此疫苗於懷孕或授乳期間使用的安全性資料。

7 交互作用

Infanrix hexa可與結合型肺炎鏈球菌疫苗、結合型腦膜炎球菌(Men) C疫苗、結合型MenACWY疫苗、MenB疫苗、輪狀病毒疫苗、麻疹疫苗、腮腺炎疫苗、德國麻疹疫苗及水痘疫苗同時接種。資料顯示，這些個別抗原所誘發的抗體反應並不會互相產生具臨床關聯性的干擾。

將Infanrix hexa與MenB疫苗及結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，在去活性小兒麻痺病毒第2型與結核型肺炎鏈球菌疫苗血清型6B抗原所引發的反應方面，各項研究中所見的結果並不一致，但這些資料並不表示產生具臨床意義的干擾。

臨床研究的資料顯示，將Infanrix hexa與結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，出現發燒反應的比例要高於單獨接種Infanrix hexa (見5. 警語及注意事項中關於結合型肺炎鏈球菌疫苗的使用指示)。

臨床研究的資料顯示，將Infanrix hexa與MenB疫苗及7價結合型肺炎鏈球菌疫苗同時接種時，發燒、注射部位疼痛、食慾喪失及易怒的發生頻率會較高。

與其它疫苗一樣，此疫苗對接受免疫抑制療法治療的患者或免疫功能缺損的患者,可能無法產生足夠的免疫反應。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

臨床試驗資料

下述的安全性數據係以獲自超過16,000名以上之受試者的資料為基礎。

如同在DTPa及含有DTPa之混合疫苗所觀察到的結果，以Infanrix hexa進行追加接種後，出現局部反應與發燒反應的病例有較進行基礎疫苗接種程序時增加的現象。

不良反應通報 依據下述頻率列出：

極常見：≥1/10，常見：≥1/100至<1/10，不常見：≥1/1000至<1/100，罕見：≥1/10000至<1/1000，極罕見：<1/10000

系統器官分類	發生頻率	不良反應
感染與寄生蟲侵染	不常見	上呼吸道感染
代謝與營養疾患	極常見	食慾喪失
精神疾患	極常見	易怒、異常啼哭、坐立不安
	常見	緊張
神經系統疾患	極常見	嗜睡
	極罕見	痙攣(併有或未併有發燒現象)***
呼吸道、胸腔與縱膈疾患	不常見	咳嗽*
	罕見	支氣管炎
胃腸道疾患	常見	嘔吐、腹瀉
皮膚與皮下組織疾患	常見	搔癢*
	罕見	皮疹
	極罕見	皮膚炎、蕁麻疹*
全身性疾患與投藥部位症狀	極常見	疼痛、發紅、注射部位局部腫脹(≤50毫米)、發燒≥38.0°C
	常見	注射部位局部腫脹(>50毫米)**、發燒>39.5°C、注射部位反應(包括硬塊)
	不常見	注射肢瀰漫性腫脹，有時並會侵犯鄰近的關節**、疲倦

*僅見於其他含有DTPa成分的GSK疫苗

**和基礎劑接種全細胞百日咳疫苗的兒童相比較，基礎劑接種非細胞性百日咳疫苗的兒童在接種追加劑之後較容易發生腫脹反應。這些反應在平均4天之後會消退。

***在上市後通報率的分析中，針對通報同時接種Infanrix hexa與 *Prevnam 13/Prevenar 13* 的嬰兒和通報僅接種Infanrix hexa的嬰兒進行比較的結果顯示，發生痙攣(併有或未併有發燒現象)及HHE的風險可能會升高。

8.3 上市後經驗

以下為在上市後監視期間所通報的藥物相關不良反應。

系統器官分類	發生頻率	不良反應
血液淋巴系統疾患	罕見	淋巴結病變、血小板減少症
免疫系統疾患	罕見	過敏反應(包括嚴重過敏反應與類過敏反應)
神經系統疾患	罕見	虛脫或休克樣狀態(低張性低反應性現象)***
呼吸道、胸腔與縱膈疾患	罕見	呼吸暫停* [見5.1警語/注意事項中關於極早產嬰兒(懷孕≤28週出生)發生呼吸暫停現象之說明]
皮膚與皮下組織疾患	罕見	血管神經性水腫*
全身性疾患與投藥部位症狀	罕見	廣泛性腫脹反應、整個注射肢腫脹**、注射部位起水泡

*僅見於其他含有DTPa成分的GSK疫苗

**和基礎劑接種全細胞百日咳疫苗的兒童相比較，基礎劑接種非細胞性百日咳疫苗的兒童較容易發生腫脹反應。

***在上市後通報率的分析中，針對通報同時接種Infanrix hexa與 *Prevnar 13/Prevenar 13* 的嬰兒和通報僅接種Infanrix hexa的嬰兒進行比較的結果顯示，發生痙攣(併有或未併有發燒現象)及HHE的風險可能會升高。

使用於早產嬰兒的安全性

在基礎疫苗接種研究中，曾針對超過1000名以上的早產嬰兒(懷孕24至36週之後出生)施打Infanrix hexa，並曾針對超過200名以上的早產嬰兒在出生後第二年以Infanrix hexa進行追加接種。在比較性研究中發現，早產嬰兒與足月嬰兒的症狀發生率大致相同。

孕期施打dTpa疫苗母親所產下之嬰兒及幼童的安全性

臨床研究中，已有超過500名在第三孕期施打dTpa疫苗(n=341)或安慰劑(n=346)的母親所生之受試者施打Infanrix hexa (見10.2 藥效藥理特性)，無論孕期有無dTpa暴露，Infanrix hexa的安全性皆相似。

B型肝炎疫苗使用經驗

在2歲以下嬰兒及幼童施打GSK出品之B型肝炎疫苗上市後監測計畫有下列反應報告：

麻痺、神經病變、腦病變、腦炎、腦膜炎、疑似血清疾病、神經炎、低血壓、血管炎、毛孔扁平苔癬、多型性紅斑症、關節炎及肌肉虛弱。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

請參閱10.2藥效藥理特性。

10.2 藥效藥理特性

藥效學

藥物治療分類：混合式的細胞性與病毒性疫苗，ATC代碼JO7CA09

免疫生成性

在臨床試驗中曾針對6週大以上的嬰兒評估Infanrix hexa的免疫生成性。這些試驗係評估依2劑或3劑基礎接種時程(包括配合擴充性免疫接種計劃的接種時程)施打此疫苗，以及使用此疫苗做為追加劑施打的結果。這些臨床研究的結果摘錄如下：

完成3劑基礎接種時程之後，有至少95.7%的嬰兒對各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。施打追加劑(第4劑)之後，有至少98.4%的幼童對各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。

以Infanrix hexa完成3劑基礎接種程序及追加劑接種程序的一個月後，抗體濃度≥分析分界點的受試者比例：

抗體 (分界點)	施打第3劑之後				施打第4劑之後 (完成3劑基礎接種時程之後，於 出生後第2年期間施打追加劑)
	2-3-4個 月大 N=196 (2項試驗)	2-4-6個 月大 N=1693 (6項試驗)	3-4-5個 月大 N=1055 (6項試驗)	6-10-14 週大 N=265 (1項試驗)	N=2009 (12項試驗)
	%	%	%	%	%
抗白喉抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	99.8	99.7	99.2	99.9
抗破傷風抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	100.0	100.0	99.6	99.9
抗PT抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0	99.8	99.6	99.9
抗FHA抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9
抗PRN抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0	99.7	98.9	99.5
抗HB抗體 (10 mIU/ml) †	99.5	98.9	98.0	98.5*	98.4
抗第1型 小兒麻痺抗體 (1/8 稀釋) †	100.0	99.9	99.7	99.6	99.9

抗第2型 小兒麻痺抗體 (1/8 稀釋) †	97.8	99.3	98.9	95.7	99.9
抗第3型 小兒麻痺抗體 (1/8 稀釋) †	100.0	99.7	99.7	99.6	99.9
抗PRP抗體 (0.15 mcg/ml) †	96.4	96.6	96.8	97.4	99.7

*在出生時未施打B型肝炎疫苗的子群嬰兒中，有77.7%之受試者的抗HB抗體濃度 ≥ 10 mIU/ml。

† 被認定為保護作用指標的分界點

N=受試者數

以Infanrix hexa完成2劑基礎劑加1劑追加劑的接種時程之後，有至少97.9%的受試者對各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。

以Infanrix hexa完成2劑基礎劑加1劑追加劑之接種程序的一個月後，抗體濃度 $\geq$ 分析分界點的受試者比例：

抗體 (分界點)	施打第3劑之後 (於2-4-12個月大時接種) N=196 (1項試驗)	施打第3劑之後 (於3-5-11個月大時接種) N=532 (3項試驗)
	%	%
抗白喉抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	100.0
抗破傷風抗體 (0.1 IU/ml) †	100.0	100.0
抗PT抗體 (5 EL.U/ml)	99.5	100.0
抗FHA抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	100.0
抗PRN抗體 (5 EL.U/ml)	100.0	99.2
抗HB抗體 (10 mIU/ml) †	99.8	98.9

抗第1型 小兒麻痺抗體 (1/8稀釋) †	98.4	99.8
抗第2型 小兒麻痺抗體 (1/8稀釋) †	98.4	99.4
抗第3型 小兒麻痺抗體 (1/8稀釋) †	97.9	99.2
抗PRP抗體 (0.15 mcg/ml) †	100.0	99.6

† 被認定為保護作用指標的分界點

N=受試者數

對白喉、破傷風、小兒麻痺、B型肝炎及Hib的血清學相關保護效果都已確立。對百日咳的血清學相關保護效果則尚未確立。不過，由於接種Infanrix hexa後對百日咳抗原所產生的免疫反應和接種Infanrix (DTPa)後相當，因此，一般認為這兩種疫苗的百日咳免疫保護效果是相同的。

對百日咳的預防效果

下表所列的研究證實了在完成3劑基礎免疫接種之後，Infanrix (DTPa)中的百日咳成分對WHO所定義之典型百日咳(陣發性咳嗽≥21天)的保護效果：

研究	國家	接種時程	疫苗保護效果	考量
家庭接觸研究 (前瞻性盲性設計)	德國	3、4、5 個月大	88.7%	根據在與典型百日咳指標病例有二度接觸之家庭成員中所收集到的資料。
保護效果研究 (NIH贊助)	義大利	2、4、6 個月大	84%	一項針對同一組受試者進行追蹤的研究證實，完成基礎接種後，在未追加接種百日咳疫苗的情況下，保護效果可維持達60個月。

孕期施打dTpa疫苗母親所產下之嬰兒及幼童的免疫生成性

有兩項臨床試驗曾針對於懷孕27-36週時接種dTpa之健康母親所生下的嬰兒與幼兒評估Infanrix hexa的免疫生成性。

對嬰兒依3劑基礎疫苗接種時程於2、4、6個月大或2、3、4個月大時合併施打infanrix hexa與13價肺炎鏈球菌接合疫苗(n=241)，或依2劑基礎疫苗接種時程於3、5個月大或2、4個月大時施打這兩種疫苗(n=27)；並於11至18個月大時對

相同的嬰兒/幼兒施打這兩種疫苗(追加劑) (n=229)。

接種基礎劑疫苗與接種追加劑疫苗之後，免疫學資料並未顯示母親接種dTpa會對嬰兒與幼兒對白喉、破傷風、B型肝炎、去活化小兒麻痺病毒、b型嗜血桿菌或肺炎鏈球菌等抗原的反應造成具臨床關聯性的干擾。

在懷孕期間接種dTpa之母親所生下的嬰兒與幼兒中，接種基礎劑後(PT、FHA和PRN)與接種追加劑後(PT、FHA)曾觀察到對抗百日咳抗原之抗體濃度較低的現象。在接種dTpa或接種安慰劑之母親所生下的嬰兒與幼兒中，從接種追加劑前到接種追加劑後1個月時間點的抗百日咳抗體濃度倍數增加幅度都落在相同的範圍之內，這表示可有效激發免疫系統。由於缺乏與百日咳保護作用的關聯性，這些觀察結果的臨床關聯性仍有待充分闡明。不過，目前的實施dTpa母體免疫接種後的百日咳疾病流行病學資料並未顯示這種免疫干擾具有任何臨床關聯性。

早產兒的免疫生成性

有3項總共收納約300名早產嬰兒(懷孕24至36週之後出生)的研究曾於完成2、4、6個月的3劑基礎接種時程之後評估Infanrix hexa的免疫生成性。也曾針對約200名早產嬰兒評估於18至24個月大時施打一劑追加劑之後的免疫生成性。

完成基礎疫苗接種的1個月後，有至少98.7%的受試者對白喉、破傷風及第1型與第2型小兒麻痺病毒產生血清保護效果；有至少90.9%的受試者對B型肝炎、PRP及第3型小兒麻痺病毒的抗原產生具血清保護性的抗體濃度；且所有受試者在抗FHA抗體與PRN抗體的檢測中都呈血清陽性反應，並有94.9%的受試者在抗PT抗體的檢測中呈血清陽性反應。

接種追加劑1個月之後，除了PT抗原(至少96.8%)與B型肝炎抗原(至少88.7%)之外，有至少98.4%的受試者對其他各種疫苗抗原產生具血清保護性或呈血清陽性的抗體濃度。追加劑所引發的反應顯示，從抗體濃度的升高倍數(15-235倍)來看，早產兒對Infanrix hexa中的所有抗原都可產生足夠的免疫反應。

在一項追蹤研究中，施打追加劑約2.5至3年之後，有85.3%的兒童對B型肝炎仍具血清保護效果，並有至少95.7%的兒童對3種型別的小兒麻痺病毒與PRP仍具血清保護效果。

免疫反應的持續性

曾針對4-8歲的兒童評估以Infanrix hexa完成3劑基礎劑加1劑追加劑之接種時程後所引發之免疫反應的持續性。有至少91.0%的兒童對3種型別的小兒麻痺病毒與PRP產生保護性免疫力，並有至少64.7%的兒童對白喉與破傷風產生保護性免疫力。有25.4%(抗PT抗體)、97.5%(抗FHA抗體)及87.0%(抗PRN抗體)的兒童在百日咳成分的抗體檢測中呈血清陽性反應。

在B型肝炎方面，以Infanrix hexa完成3劑基礎劑加1劑追加劑的接種時程之後，有≥85%的4-5歲的受試者，≥72%的7-8歲的受試者，≥60%的12-13歲的受試者，及53.7%的14-15歲的受試者仍具有血清保護抗體濃度。此外，在完成2劑基礎劑加1劑追加的接種時程之後，有≥48%的11-12歲的受試者對B型肝炎仍具有血清保護抗體濃度。

4至15歲的兒童都證實具有B型肝炎免疫記憶。這些兒童都曾在嬰兒時期使用Infanrix hexa進行基礎接種和追加接種，且於另外施打一劑單價HBV疫苗之後，有至少93%的受試者可觀察到保護性免疫力。

上市後的使用經驗

在瑞典長期追蹤的結果顯示，嬰兒依出生後第3及第5個月的基礎接種時程接種非細胞性百日咳疫苗，並於出生後第12個月左右接種一劑追加劑，確可達到保護的效果。不過，資料顯示，對百日咳的預防效果在7-8歲時可能會逐漸減弱。這表示先前依此時程接種疫苗的兒童必須在5-7歲時接種第二劑百日咳疫苗追加劑。

在德國的一項廣泛上市後監視研究曾針對Infanrix hexa之Hib成分的預防效果進行探討。7年的追蹤結果顯示，含有Hib成分的兩種六價疫苗(其中一種即為Infanrix hexa)於完成完整基礎接種後的預防效果為89.6%，於施打完整基礎接種和追加劑之後的預防效果則為100%(不考慮首次接種的Hib疫苗)。

自2006年以來，Infanrix hexa一直都是義大利主要的含有Hib成分的疫苗。此疫苗係於3、5及11個月大時施打，且覆蓋率已超過95%。在2006年至2011年期間，5歲以下之義大利兒童中的Hib疾病一直都受到良好的控制，每年通報的Hib確定病例不超過3例。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

請參閱10.2藥效藥理特性。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

DTPa-HBV-IPV懸浮液盛裝於預充填注射針筒中。

Hib疫苗成分盛裝於玻璃小瓶中。

裝有1劑量的粉末並附有瓶塞（丁基橡膠）的小瓶（第I型玻璃）。裝有0.5毫升懸浮液的預充填注射針筒（第I型玻璃），附有一推桿活塞（丁基橡膠）及一個橡膠前蓋。

預充填注射針筒的前蓋及橡膠推桿活塞和小瓶之瓶塞皆非天然橡膠乳膠製成。

包裝規格有一組、十組及五十組裝，附有或未附有針頭。

並非每一個國家都會上市所有的包裝規格。

13.2 效期

保存期限標示於標籤及外盒上。

13.3 儲存條件

冷藏(2°C-8°C)貯存。DTPa-HBV-IPV懸浮液及泡製後的疫苗切勿冷凍；如果已經冷凍，則應丟棄不用。

請避光貯存。

運送期間，應比照建議的貯存條件。

安定性試驗的數據顯示，疫苗成分在不超過25°C的溫度下可維持安定72小時。這些數據的目的僅為在溫度短暫變動時做為健康照護人員的參考指標。

本品應置於兒童不及之處。

貯存條件詳見外包裝。

15 其他

不相容性

Infanrix hexa不應與其它疫苗混合於同一針筒中使用。

使用及操作

應將DTPa-HBV-IPV懸浮液充分振搖，以形成均勻的混濁白色懸浮液。應檢視DTPa-HBV-IPV懸浮液和Hib粉末中是否有異物及(或)物理性質方面的變化。如果發現任何這類現象，則不應使用此疫苗。

在泡製Infanrix hexa時，應將預先充填針筒的內容物完全注入內含Hib粉末的小瓶內。

臨床上合適的做法是，疫苗應等到與室溫相同時再注射。此外，當瓶身溫度和室溫相同時可確保塑膠瓶蓋之彈性以減少塑膠粒子產生。因此，泡製疫苗時應把瓶身置於室溫(25 ± 3 °C)下最少五分鐘再使用。

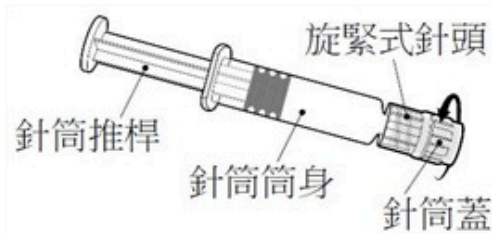
泡製後的疫苗會形成比原來只有液態成分時略為更混濁的懸浮液。這是正常現象。

應檢視泡製後的疫苗中是否有任何微粒異物及(或)物理外觀異常的現象。如果發現任何這類現象，則不應使用此疫苗。

此疫苗在泡製之後應立即使用。但此疫苗可在室溫(21°C)下保存達8小時。

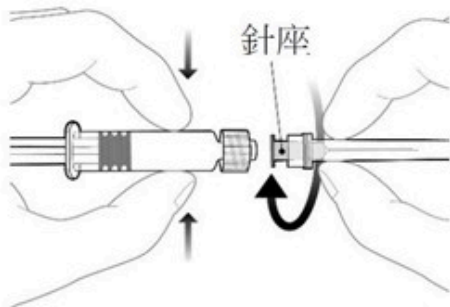
取出所有玻璃小瓶中之內容物。

預充填注射針筒使用指示



握住針筒筒身，請勿握住針筒推桿。

逆時鐘方向旋轉將針筒蓋轉下來。



將針頭裝上針筒。針座接上旋緊式接頭後順時鐘轉 4 分之 1 圈，直到感到鎖緊為止。

如上所述回溶疫苗。

勿將針筒推桿拉出筒身外，如發生此情形請勿施打該疫苗。

廢棄物處置：

任何未使用的疫苗或廢棄物都應依照當地的規定處理。

版本編號：GDS22/IP17

版本日期：12 Aug 2022

訂閱...



(<https://accessibility.moda.gov.tw/Applications/Detail?category=20230922142826>)



衛生福利部食品藥物管理署
Food and Drug Administration

本網站所刊出內容之著作權屬於衛生福利部食品藥物管理署所有，未經本署之同意或授權，任何人不得以任何形式重製、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部，亦不得為其他任何違反本署著作權之行為。

☎ 服務專線：02-7737-2958

✉ 服務信箱：mcp@tradevan.com.tw

🕒 服務時間：週一～週五08:30~17:30

Copyright © 2019 衛生福利部食品藥物管理署

Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare. All rights reserved.